

MATAVICIOS · GUÍA PRÁCTICA PARA ADULTOS

Uso de pornografía que **te preocupa**.

Herramientas de autoobservación y cambio para cuidar tu bienestar, atención, límites y relaciones sin moralizar ni etiquetarte.

Metas elegidas

No diagnóstico

Bienestar y seguridad

Antes de empezar. Este es un material educativo de autoayuda. No diagnostica, no prescribe tratamientos y no sustituye la valoración de medicina, enfermería, farmacia, psicología o psiquiatría.

Úsalo para observar tu patrón, probar cambios pequeños y pedir apoyo cuando lo necesites. No se trata de demostrar fuerza de voluntad ni de seguir una racha perfecta. Se trata de ganar margen de elección.

Cómo está organizado

MÓDULO 0

Comprender sin etiquetarte

MÓDULO 1

Ver el patrón completo

MÓDULO 2

Crear una pausa y diseñar el entorno

MÓDULO 3

Pensamientos, emociones y valores

MÓDULO 4

Cuerpo, descanso y salud sexual

MÓDULO 5

Relaciones, límites y conversación segura

MÓDULO 6

Revisar un episodio sin castigarte

MÓDULO 7

Continuar con elección

MÓDULO 0

Comprender sin etiquetarte

Esta guía sirve para personas adultas a quienes su uso de pornografía les preocupa o les interfiere. No parte de la idea de que toda pornografía, masturbación o deseo sexual sea un problema.

Una distinción importante

“Uso problemático de pornografía” (PPU) es un **término de investigación**, no un diagnóstico por sí mismo. Puede describir un uso que la persona percibe como difícil de controlar y asociado a malestar o interferencia. En ICD-11, el trastorno de conducta sexual compulsiva requiere un patrón persistente de control deteriorado sobre conductas sexuales repetitivas, habitualmente durante seis meses o más, con deterioro o malestar marcado; la valoración la realiza un profesional. El malestar explicado solo por desaprobación moral o social no basta para ese diagnóstico. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Frecuencia, deseo sexual alto, masturbación o pornografía no son por sí mismos una enfermedad. La pregunta útil es: “¿Tengo elección y esta conducta encaja con mi bienestar y mis límites?”

La meta no viene impuesta

Puedes elegir reducir, pausar, cambiar el contexto de uso, dejar de usar durante un tiempo o simplemente entender qué ocurre. Una meta funcional y breve suele ser más útil que una promesa total basada en miedo o vergüenza.

HERRAMIENTA · MI EXPERIMENTO DE DOS SEMANAS

El cambio que quiero probar: _____

El área que quiero cuidar: sueño / atención / relación / tiempo / tranquilidad / otra: _____

Cómo sabré si me está ayudando: _____

Semáforo de apoyo

Verde · Autoobservación

Hay margen de elección, no hay riesgo inmediato y quieres probar un cambio pequeño y revisable.

Ámbar · Pide cita

Notas pérdida de control persistente, deterioro importante, angustia intensa, problemas de salud sexual, trauma, sustancias o ánimo que necesitas comprender.

ROJO · PRIORIZA SEGURIDAD

Busca atención urgente local ante riesgo de daño a ti o a otra persona, conducta no consentida, coerción, violencia, crisis suicida, confusión intensa o incapacidad para mantenerte a salvo. Este curso no sustituye esa atención.

MÓDULO 1

Ver el patrón completo

El objetivo del registro es convertir una experiencia automática en información. No presupone que una emoción, una pantalla o una necesidad concreta sea la causa.

Mapa personal: antes, durante y después

CONTEXTO	QUÉ NOTÉ/PENSÉ	QUÉ HICE	QUÉ BUSCABA O NOTÉ A CORTO PLAZO	QUÉ PASÓ DESPUÉS
En la cama con el móvil	Cansancio, "solo un rato"	Empecé a navegar	Distracción o placer	Dormí más tarde de lo que quería
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Evita escribir “dopamina” como explicación. Registra efectos observables: placer, distracción, relajación, activación, sueño, curiosidad, soledad, tiempo o malestar.

Contextos posibles, no causas universales

Soledad, aburrimiento, estrés, insomnio, redes sociales, habitación, conflicto o tiempo a solas pueden formar parte de un patrón para algunas personas. También puede haber contextos donde el impulso baja. Añade ambos: **riesgos y factores protectores**.

PRÁCTICA · SIETE OBSERVACIONES

Durante una semana, registra solo una línea por ocasión o impulso: situación, intensidad de 0 a 10, elección hecha y efecto cinco o diez minutos después. Si no hubo uso, también cuenta: te enseña qué ayuda.

No atribuyas síntomas de forma automática

Dificultades de erección, libido, sueño o ánimo pueden tener causas médicas, psicológicas, relacionales, farmacológicas y de estilo de vida. No concluyas que la causa es la pornografía ni que la solución es una “racha”. Si algo es persistente, doloroso o te preocupa, pide una valoración médica o de salud sexual.

MÓDULO 2

Crear una pausa y diseñar el entorno

La meta no es eliminar todos los pensamientos sexuales. Es crear una pausa suficiente para que la conducta sea una decisión y no solo una secuencia automática.

Plan breve ante un impulso

1. **Detecta la señal temprana:** una pestaña, el móvil en la cama, aburrimiento, una frase como “solo cinco minutos”.
2. **Haz una pausa de dos a diez minutos:** nombra la urgencia y respira de forma cómoda.
3. **Cambia una condición:** deja el móvil fuera, cambia de habitación, pon una alarma, abre una actividad elegida o escribe a alguien.
4. **Reevalúa:** puntúa la urgencia de 0 a 10 y decide de nuevo.

Esto es una herramienta conductual de autoayuda, no una terapia HRT ni una prueba de fuerza de voluntad. Si una práctica corporal, de respiración o de atención interna aumenta pánico, disociación o malestar, detente y usa una alternativa orientada al entorno.

Dos planes si-entonces

Mi primer plan

Si _____
entonces primero haré _____
si el impulso sigue alto, _____
y registraré: _____

Mi segundo plan

Si _____
entonces primero haré _____
si el impulso sigue alto, _____
y registraré: _____

Higiene digital flexible

Los bloqueadores, límites de apps, modo sin notificaciones o cargar el móvil fuera del dormitorio pueden ser opciones si encajan contigo. No son requisitos, no demuestran “recuperación” y no sustituyen el trabajo sobre el contexto. Elige **dos cambios reversibles** y revisa si te ayudan sin aumentar el aislamiento, la vigilancia o la vergüenza.

MÓDULO 3

Pensamientos, emociones y valores

Cambiar no exige negar lo que sientes. Exige poder notar una urgencia, explorar qué necesitas y elegir una acción coherente con lo que te importa.

Preguntar antes de corregir

La reestructuración cognitiva no consiste en reemplazar una frase por un eslogan opuesto. Usa cuatro preguntas:

1. ¿Qué estoy diciendo que necesito ahora?
2. ¿Qué evidencia veo en mis propios registros?
3. ¿Qué necesidad puede haber debajo: descanso, placer, conexión, desconexión, curiosidad?
4. ¿Cuál es una alternativa equilibrada que puedo probar durante unos minutos?

PENSAMIENTO	LO QUE OBSERVO	ALTERNATIVA EQUILIBRADA
"Lo necesito para dormir"	Me da rutina, pero a veces me deja despierto más tarde.	"Ahora quiero desconectar. Probaré 15 minutos de una rutina sin pantalla y revisaré después."
_____	_____	_____

Defusión y contacto con el presente

Una frase de defusión puede ser: **“Estoy notando una urgencia y el pensamiento de que debo actuar ahora.”** No intenta borrar el deseo. Intenta separar la experiencia de la orden. Después, lleva la atención a cinco cosas que ves, cuatro que sientes al tacto, tres que oyes, dos que hueles y una que saboreas, o elige otra actividad de tu plan.

Valores sin presión moral

Los valores no son una lista de reglas sexuales “correctas”. Son cualidades que quieres expresar de forma consensuada, legal, segura y propia: honestidad, descanso, autonomía, conexión, curiosidad, cuidado, tiempo o privacidad.

PRÁCTICA · UN VALOR, UNA ACCIÓN

Valor que quiero cuidar: _____

Acción de menos de diez minutos: _____

Cuándo la haré esta semana: _____

MÓDULO 4

Cuerpo, descanso y salud sexual

No existe un “reseteo” de 30, 60 o 90 días ni una curva universal de recuperación. El sueño, el deseo y el ánimo cambian por muchos factores.

Rutinas que puedes experimentar

Prueba actividades agradables, seguras y accesibles para crear un cierre del día o una pausa: lectura en papel, música, una bebida sin alcohol si te sienta bien, estiramientos suaves, una ducha, escribir, una llamada, una tarea manual o simplemente descansar. No hay necesidad de usar duchas frías, ejercicio intenso ni explicaciones de “dopamina” para que una rutina sea válida.

Body scan y atención plena como opciones

A algunas personas les sirve recorrer el cuerpo con atención, desde los pies hasta la cara, nombrando sensaciones sin forzarlas. A otras les incomoda cerrar los ojos o prestar atención interna. Si es tu caso, mantén los ojos abiertos, describe

objetos del entorno o elige una tarea externa. La práctica es opcional y debe sentirse suficientemente segura.

Panel semanal de bienestar

SEMANA	ELECCIÓN/CONTROL 0-10	SUEÑO 0-10	ÁNIMO 0-10	INTERFERENCIA 0-10	QUÉ APRENDÍ
1	___	___	___	___	_____
2	___	___	___	___	_____
3	___	___	___	___	_____
4	___	___	___	___	_____

Mide bienestar y funcionamiento, no solo días sin uso. Si el ánimo, el sueño o la función sexual empeoran o te preocupan, añade consulta profesional al plan.

MÓDULO 5

Relaciones, límites y conversación segura

La intimidad puede ser afectiva, sexual, amistosa o ninguna de estas según la persona. La guía no presupone pareja, orientación, género ni un único ideal de sexualidad.

No hay una confesión obligatoria

Considera hablar con una pareja solo si es seguro y útil para ti. Antes, define qué deseas compartir, qué límite de privacidad necesitas y qué acción concreta vas a asumir. No conviertas a tu pareja en terapeuta ni prometas cambios que aún no sabes cómo sostener.

SEGURIDAD RELACIONAL

Si existe miedo, coerción, violencia, control o riesgo de represalia, prioriza apoyo profesional o un servicio de seguridad antes de revelar información personal. Tu seguridad va primero.

Guion breve y respetuoso

PRÁCTICA · CONVERSACIÓN ACORDADA

“Me gustaría hablar de cómo cuidar nuestra relación y mis límites. ¿Es un buen momento?”

“No te pido que seas mi terapeuta. La acción concreta que voy a probar es _____.”

“¿Qué límites y apoyos serían respetuosos para ambos?”

Conexión elegida

Si quieres más conexión, elige una acción social, comunitaria o de autocuidado que sea compatible con tus preferencias: escribir a alguien, participar en una actividad, buscar apoyo profesional o reservar tiempo de calidad. La soledad puede coexistir con el uso de pornografía o no; explora la necesidad presente sin juzgarla.

MÓDULO 6

Revisar un episodio sin castigarte

Si ocurre algo distinto de lo que habías planeado, no necesitas llamarlo “recaída” ni empezar de cero. Úsalo como datos para revisar tu meta y pedir apoyo si hace falta.

Revisión compasiva

Pregúntate: ¿qué contexto había?, ¿qué necesidad intentaba atender?, ¿qué parte del plan no era realista?, ¿qué protección o apoyo faltó?, ¿cuál es un ajuste pequeño para la próxima situación? Evita convertir el episodio en una identidad o en una prueba de que no puedes cambiar.

Plan de las próximas 24–48 horas

Mi revisión

Lo que ocurrió, en una frase:

La necesidad o contexto que detecto:

Un ajuste del entorno o plan:

Apoyo que puedo pedir:

Retoma la meta en la siguiente decisión; no esperes una fecha perfecta. Si el uso se percibe persistente, fuera de control o muy dañino, una evaluación puede aportar más de lo que una guía autoguiada puede ofrecer.

Cuándo consultar

Pide ayuda profesional si percibes pérdida de control persistente, deterioro relevante, angustia que no se explique solo por conflicto moral, trauma, depresión, ansiedad intensa, uso de sustancias, cambios marcados de ánimo, dificultades sexuales persistentes o conductas no consentidas o de riesgo. La evaluación busca comprender el conjunto, no etiquetarte.

MÓDULO 7

Continuar con elección

El cambio sostenible suele ser un proceso de prueba, revisión y apoyo. No hay una duración universal ni un número de días que “arregle” a una persona.

Plan revisable de dos a cuatro semanas

Elige una fecha de revisión y mira tu panel de bienestar. Pregunta: ¿mi meta me ayuda?, ¿qué situación sigue siendo difícil?, ¿qué apoyo he usado?, ¿hay que simplificar, cambiar o pedir una consulta?

MI PRÓXIMO CICLO

Meta observable y voluntaria: _____

Señal de que necesito más apoyo: _____

Fecha de revisión: _____

El método en una página

MI SECUENCIA

1. Noto el contexto. **2.** Creo una pausa. **3.** Cambio una condición. **4.** Reevalúo la urgencia. **5.** Actúo según un valor elegido. **6.** Registro lo aprendido y ajusto sin vergüenza.

Una nota de evidencia honesta

Las revisiones encuentran resultados prometedores de intervenciones psicológicas con componentes cognitivo-conductuales y de aceptación para personas que buscan ayuda por PPU. Sin embargo, los estudios son todavía limitados, heterogéneos y con riesgo de sesgo. Eso no invalida las herramientas; significa que no deben venderse como tratamiento garantizado ni como explicación única de una experiencia sexual. [\[3\]](#) [\[4\]](#)

Apoyo y recursos

Atención primaria, psicología o psiquiatría

Pide una evaluación si hay pérdida de control, deterioro, trauma, ánimo intenso, sustancias o dudas de salud sexual.

Profesional de salud sexual

Útil ante dificultades persistentes de erección, deseo, dolor o preocupaciones sexuales que merecen una valoración completa.

Emergencias locales

Úsalas ante riesgo inmediato, violencia, coerción, conducta no consentida o crisis suicida.

Privacidad digital

No compartas diarios, capturas ni detalles sexuales sensibles en comunidades no moderadas.

Fuentes y transparencia

Las herramientas de esta guía se inspiran en enfoques conductuales, cognitivos y de aceptación. La evidencia no permite garantizar un resultado individual ni convertir esta guía en terapia. Las fuentes se incluyen para que puedas comprobar qué se sabe y qué límites tiene.

1. [World Health Organization. ICD-11: 6C72 Compulsive sexual behaviour disorder.](#)
2. [Kraus SW, et al. \(2018\). Compulsive sexual behaviour disorder in the ICD-11. World Psychiatry.](#)
3. [López-Pinar C, Esparza-Reig J, Bóthe B. \(2025\). Psychotherapy for problematic pornography use: a comprehensive meta-analysis.](#)
4. [Roza TH, et al. \(2024\). Treatment approaches for problematic pornography use: a systematic review.](#)
5. [Crosby JM, Twohig MP. \(2016\). Acceptance and Commitment Therapy for problematic internet pornography use: a randomized trial.](#)
6. [Mayo Clinic. Compulsive sexual behavior: diagnosis and treatment.](#)